

46 - 05-Le syndrome de l'insuffisance hépatocellulaire - Pr. Samlani

Le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire Le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques en rapport avec une diminution ou un arrêt des fonctions des hépatocytes. Il faut s'aider en insuffisance hépatocellulaire aiguë et insuffisance hépatocellulaire chronique. Les manifestations sont polymorphes et les causes sont multiples, dominées par des causes aiguës telles que l'hépatite aiguë et des causes chroniques telles que la cirrhose du foie.

Il est nécessaire de connaître l'anatomie microscopique du foie pour comprendre les fonctions du foie. Dans une coupe histologique du foie, on reconnaît les unités par enchimamenteuse hexagonale ou lobule, qui sont les unités fonctionnelles du foie. On voit les hépatocytes qui sont agencés en travées de rémac, qui convergent vers le centre du lobule.

A la périphérie, on a des espaces portes dont chacun contient une triade portale, un petit canal biliaire, une artériole branche l'artère hépatique, une vénule branche la veine porte. Les ramifications de la vénule portale et celles de l'artériole hépatique vont assurer la vascularisation du lobule en se jetant dans les sinusoides. Les sinusoides, ce sont des petits espaces vasculaires qui alternent avec les travées cellulaires et qui oufluent vers les veines centrolobulaires.

Les veines centrolobulaires vont confluer elles-mêmes pour former les veines sucépatiques. Le foie a de multiples fonctions. Il a des fonctions d'homéostasie, dans l'équilibre glycémique et dans la régulation des lipides.

Il a des fonctions de synthèse, notamment de certaines protéines telles que l'alumine, les protéines d'inflammation, les facteurs de coagulation. Dans la sécrétion biliaire, il a une fonction d'épuration, des médicaments, des métabolites liposolubles. Il a aussi un rôle dans le métabolisme hormonal, notamment des oestroprogestatifs.

Cela implique que toute atteinte hépatique, toute insuffisance hépatocellulaire aura des conséquences sur l'équilibre glycémique, sur le métabolisme des lipides, sur les fonctions de synthèse de certaines protéines, notamment les protéines de l'inflammation, sur la coagulation, sur la sécrétion biliaire, sur les fonctions d'épuration et sur le métabolisme hormonal. Le diagnostic positif de l'insuffisance ou du syndrome d'insuffisance hépatocellulaire repose sur des critères cliniques. Le signe le plus important qui est constant est l'asthémie.

C'est une fatigue importante que le patient va vous décrire. L'ictère est un signe qui est quasi constant mais qu'on ne retrouve pas à 100%. Il y a également le foëtor hépaticus.

Le foëtor hépaticus est une odeur fruitée, douçâtre de la laine que le patient va émettre. L'élément le plus important est l'encéphalopathie hépatique. L'encéphalopathie hépatique est un ensemble de manifestations neuropsychiatriques de stade variable et qui va renseigner sur le

degré et la profondeur de l'insuffisance hépatocellulaire.

Ça va du stade 1 où il y a un astérisis. L'astérisis, c'est une interruption brusque et brève du tonus de base des mains. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.

Le patient que vous examinez qui lève les bras vers vous en écartant les doigts de la main sera incapable de maintenir son tonus. Le stade 2 est la présence d'un astérisis avec un syndrome confusionnel. Le stade 3, le patient est dans un état stuporeux, c'est-à-dire qu'il est en quasi stupeur avec une somnolence marquée.

Il a un discours qui est inapproprié. Et le stade 4 est le stade maximal où il y a un coma qui est sans signe de localisation avec une hypertonie et une polypnée. Vous voyez ici l'astérisis, les doigts du patient quand vous l'examinez, avec une incapacité, un tremblement minime et une incapacité de maintenir un tonus de base.

Autres signes cliniques, ce sont manifestations cutanéophanériennes. Vous voyez l'enjeun stellaire, ce sont des petites lésions qui se présentent sous la forme d'un point rouge entouré d'une couronne de fins vaisseaux en étoile qui s'efface à la vitropression qui le taille variable allant de quelques millimètres à un centimètre de diamètre. Il siège à la partie supérieure du corps en général au niveau des zones découvertes, au niveau de la face, du cou et du dos des mains.

L'erythrose palmaire, c'est une coloration rouge violacée des éminences ténard-hypoténard et de la pulpe des doigts qui est due à une vaste dilatation des capillaires sous-cutanés et qui s'efface également à la vitropression. L'hypocratisme digital n'est pas spécifique à l'insuffisance hépatocellulaire, mais on risque de le trouver dans l'insuffisance hépatocellulaire chronique. C'est une déformation des doigts qui prend la forme d'une spatule ou d'une baguette.

Les ongles blancs, on recherche également des signes endocriniens. Chez la femme, la ménorrhée secondaire, la stérilité, une atrophie mammaire. Chez les hommes, une impuissance sexuelle, une atrophie testiculaire, une féminisation, une gynécomastie, voire une dépilation.

On recherche également des signes hémorragiques, des hémorragies gingivales, des gencives qui sont fragiles. On pose la question au patient si ses gencives saignent quand il se brosse les dents. Un épistaxis, un purpura, des échymoses faciales ou des échymoses inexplicables et un œdème des membres inférieurs.

Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, on peut également retrouver des manifestations cardiovasculaires, un syndrome d'hypersynésie circulatoire avec une tachycardie, une diminution du débit cardiaque, une diminution de la tension artérielle. Les principaux signes biologiques qu'il faut rechercher et qui permettent d'évaluer le degré de l'insuffisance hépatocellulaire, c'est une diminution des facteurs de coagulation, en particulier le facteur 5, ce qui est le plus spécifique, du taux de prothrombine qui n'est pas corrigé par l'administration du vitamine K, c'est ce qu'on appelle

un test de cholère négatif, une insuffisance hépatocellulaire est dite sévère si le taux de prothrombine est inférieur à 50% de la normale. On recherche également l'hypoalbuminémie qui est parallèle à la sévérité de l'atteinte hépatique, une hypocholestérolémie totale et stérifiée, une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée ou mixte.

Il faut savoir que les hépatocytes sont en état de souffrance, la fonction de glucoréconjugaison risque d'être conservée, mais la fonction d'excrétion ne l'est pas, donc il y aura un reflux, une régurgitation à la fois du bilirubine libre et du bilirubine mixte conjugué, une hyperammoniémie secondaire à un déficit d'épuration azotée, une hypoglycémie secondaire à un trouble de l'équilibre glycémique. À ce stade-là, on peut différencier et on doit différencier l'insuffisance hépatocellulaire aiguë et l'insuffisance hépatocellulaire chronique. Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire aiguë, il y a des formes extrêmement graves, c'est le cas de l'hépatite fulminante.

On parle d'hépatite fulminante quand le délai d'apparition des symptômes est inférieur à 15 jours, quand le TP est inférieur à 50% avec une encéphalopathie et c'est une urgence qui nécessite la transplantation hépatique. Cette insuffisance hépatocellulaire peut être subfulminante quand elle est supérieure à 15 jours. Enfin, on parle d'insuffisance hépatocellulaire chronique quand il y a apparition de beaucoup de symptômes cliniques et que ça se passe dans le temps.

Alors quels sont les diagnostics différentiels au cours de l'insuffisance hépatocellulaire ? Pour les encéphalopathies, il faut différencier l'encéphalopathie hépatique des autres encéphalopathies, notamment rénale, carencielle par carence vitaminique, le délirium tremens secondaire à un sevrage éthylique, une éventuelle méningite. L'astérisisme peut provoquer ou plutôt peut prêter à confusion avec d'autres tremblements involontaires, notamment la maille de Parkinson. Les angiomes stellaires peuvent poser un diagnostic différentiel avec les télangiectasies qui, contrairement à l'angiome stellaire, persistent à la vitre aux pressions.

Il peut y avoir aussi un diagnostic différentiel avec les varicosités, avec le purpur. Pour les éléments biologiques, l'hypoalbuminémie peut se rencontrer dans le syndrome néphrotique, dans le syndrome de malabsorption. Dans ce cas-là, le facteur 5 est normal.

Et la baisse du taux de prothrombine peut se voir aussi au cours de la cholestase isolée. Mais dans ce cas-là, le test de colère est positif. À ce stade-là, il faut faire le diagnostic étiologique.

Le diagnostic étiologique passe par une enquête étiologique avec l'enquête sur l'âge, les antécédents personnels de consommation d'alcool, la quantité et la durée, la prise médicamenteuse prolongée, la prise de toxiques et de plantes, les facteurs de vie d'hépatite virale, que ce soit les scarifications, la toxicomanie, la notion d'extraction dentaire informelle, la notion de transfusion, d'accouchement à domicile, les rapports sexuels non protégés, les tatouages, les antécédents personnels et familiaux d'hépatopathie connue ou de maladie autoïne. L'examen clinique doit être complet. C'est un examen abdominal, mais également un

examen général avec toutes les erreurs.

Et à l'examen abdominal, on recherche à l'inspection les signes d'hypertension portale, la circulation collatérale, on palpe pour rechercher une splénomégalie, on percute, on recherche une ascite et on examine le foie avec sa surface, avec son bord inférieur. Et bien sûr, on examine le patient en totalité à la recherche de signes d'alcoolisme chronique, d'hypertrophie parotidienne, d'erythrose, d'épaule. On réalise un bilan biologique complet, avec un bilan hépatique, avec les transaminases, ALAT, ASAT, à la recherche d'une cholestase.

Avec les enzymes de cholestase, qui sont les gamma-GT, les phosphatase alcaline, les 5 primes nucléotidase. On fait une numération en formule sanguine pour voir s'il n'y a pas de macrocytose, une anémie, une hyperleucocytose, aplasie myéloïde. Quand on suspecte une hépatite virale ou cholestase virale, on réalise les sérologies appropriées.

Quand on suspecte une maladie auto-immune, une hépatopathie auto-immune, on fait les anti-K anti-nucléaire, anti-musclodysse, les anti-K anti-K à les mains. Et quand on pense à un problème de Meyne-de-Wilson, on réalise une séroplastie mine cuprémine ou cuprémine. Au terme de cela, l'examen radiologique le plus important pour nous, c'est l'échographie abdominale, avec Doppler.

Parce qu'elle permet d'étudier les caractères du foie, mais également d'étudier les veines susses hépatiques, le trompe-porte, rechercher s'il n'y a pas une circulation collatérale, voir la présence d'une ascite et voir la présence d'une ascite. Et on peut compléter également cet examen par une tomodensitométrie ou par une imagerie par résonance magnétique au besoin. Les principales étiologies sont les hépatites aiguës.

Il s'agit d'une atteinte inflammatoire et nécrosante du tissu hépatique responsable d'une diminution de la fonction hépatique. Sont responsables de cela des hépatites virales aiguës, des hépatites médicamenteuses. Il faut noter le rôle néfaste du paracétamol pour le foie, des hépatites toxiques et alcooliques, des hépatites auto-immunes.

Et la Meyne-de-Wilson qui est une maladie héréditaire caractérisée par la surcharge en cuivre. Parmi les étiologies de la cholestase hépatocellulaire aiguë, le syndrome de Butcher qui est une obstruction aiguë des veines susses hépatiques qui va entraîner une congestion du foie. La stéatose aiguë gravitique que l'on trouve chez la femme enceinte.

L'ischémie aiguë du foie qui est appelée aussi foie de choc, qui est secondaire à une diminution du débit hépatique et qui sera responsable d'une diminution de l'oxygénation des hépatocytes. Le foie cardiaque qui est la conséquence du retentissement d'une cardiopathie chronique sur le foie. Parmi les étiologies de la cholestase hépatocellulaire chronique, on retrouve les hépatites chroniques qui sont l'évolution naturelle des hépatites aiguës avec l'apparition d'une inflammation chronique et une destruction des hépatocytes.

La cirrhose hépatique qui complique la suissance hépatocellulaire. La cirrhose est le dénouement de toutes les maladies chroniques. C'est une destruction irréversible du parenchyme hépatique et l'infiltration tumorale du foie.

En conclusion, la suissance hépatocellulaire est une urgence qui traduit l'incapacité du foie à assurer ses fonctions. Il faut en rechercher l'étiologie et assurer un traitement adapté. Et pour les formes graves, notamment fulminantes, c'est la transplantation hépatique qui indique.